Anafilaxia: manejo inicial

Diagrama de flujo · Alergología · KronosMedicine

Sospecha: inicio súbito de piel o mucosas + compromiso respiratorio o cardiovascular

↓

Adrenalina IM en el muslo: 0.01 mg/kg (máx. 0.5 mg adulto, 0.3 mg niño)

↓

Retirar el alérgeno · posición supina con piernas elevadas · oxígeno · líquidos IV

↓

¿Mejora en 5–15 minutos?

No → repetir adrenalina IM, más líquidos; si persiste, infusión IV en UCI

Sí ↓

Segunda línea: antihistamínico H1, salbutamol si hay sibilancias, esteroide

↓

Observar 6–12 h (reacción bifásica) · triptasa sérica

↓

Alta: autoinyector de adrenalina, plan escrito, brazalete y envío a Alergología